

Стрессовое недержание мочи — Женщины

Информация для пациента · Подтекание мочи при кашле, смехе, подъёме тяжестей или физической нагрузке

WARWIKI

Стрессовое недержание мочи (SUI) — это непроизвольное подтекание мочи при резком повышении давления в животе: при кашле, чихании, смехе, подъёме тяжестей или физической активности. У женщин это происходит при ослаблении поддержки уретры — чаще после родов или в период менопаузы. Состояние очень распространено и хорошо поддаётся лечению: от простых упражнений до быстрой и высокоэффективной операции.

Об этом состоянии

Уретра (мочеиспускательный канал, по которому моча выходит из тела) в норме остаётся закрытой при кашле или натуживании благодаря поддержке тазового дна и окружающих тканей. При ослаблении этой поддержки резкий рост давления в животе приводит к вытеканию мочи. Главный признак — **подтекание при нагрузке**, а не при внезапном позыве (это гиперактивный мочевой пузырь; наличие обоих типов называется **смешанным** недержанием).

Причины

- **Беременность и роды** (ведущая причина)
- **Менопауза** и возрастные изменения
- Хронический кашель, запоры или подъём тяжестей
- Избыточный вес и перенесённые операции на органах малого таза

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание

Подтекание мочи при нагрузке — кашле, подъёме тяжестей, физической активности.

Уретра

Трубка, по которой моча выводится из организма.

Тазовое дно

Мышцы, поддерживающие мочевой пузырь и уретру.

Упражнения Кегеля

Сжатие мышц тазового дна для укрепления поддержки.

Смешанное недержание

Сочетание стрессового подтекания и ургентного недержания.

Пессарий / вкладыш

Небольшое поддерживающее устройство во влагалище для уменьшения подтекания.

Буллинг уретры

Офисная инъекция, помогающая уретре лучше смыкаться.

Mid-urethral sling

Небольшая сетчатая поддержка, устанавливаемая под уретрой во время операции.

НУЖНА ЛИ МНЕ ОПЕРАЦИЯ? Не обязательно. Многие женщины улучшают состояние с помощью упражнений для тазового дна и простых изменений образа жизни, другие используют поддерживающее устройство. Операция (например, слинг) очень эффективна при желании получить долгосрочный результат — но это ваш выбор, и можно начать с более простых шагов.

Как это диагностируют

- Беседа о ситуациях, при которых возникает подтекание, и осмотр (иногда проба с кашлем)
- **Анализ мочи** для исключения инфекции и оценка полноты опорожнения мочевого пузыря
- При необходимости — уродинамическое исследование перед операцией

Как это лечат (пошагово)

- 1 **Упражнения для тазового дна** (Кегеля) и физиотерапия, снижение веса, лечение кашля и запоров.
- 2 **Поддерживающие устройства** — вагинальный пессарий или безрецептурный вкладыш.
- 3 **Буллинг уретры** — быстрая офисная инъекция для улучшения смыкания уретры.
- 4 **Операция — mid-urethral sling** (или аутологичный фасциальный слинг) для долгосрочного устранения проблемы. Для каждого варианта есть отдельный листок.

Жизнь с SUI

- Научитесь **сжимать мышцы тазового дна перед кашлем, чиханием или подъёмом тяжестей** («приём предупреждения»).
- Выполняйте упражнения ежедневно — результат проявляется через 6–12 недель.
- Устраняйте запоры и хронический кашель, которые усиливают давление.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Жжение, urgentные позывы или **кровь в моче** (возможная инфекция)
- Подтекание при **сильном позыве** — лечение может отличаться
- Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. SUI у женщин — подтекание мочи при нагрузке вследствие ослабленной поддержки уретры: состояние распространённое и хорошо поддающееся лечению.
2. Варианты лечения: от упражнений и поддерживающего устройства до офисной инъекции для уретры и слинга для долгосрочного результата.
3. Упражнения требуют нескольких недель; сжимайте мышцы перед кашлем или подъёмом тяжестей. Операция — это выбор, а не обязанность.